LES PLAIES • MISSION OBSERVATION !

RECTO • Reconnaître les types de plaies, les phlyctènes et les zones à risque

1 • TYPES DE PLAIES

Aiguë : traumatique (coupure, déchirure), chirurgicale ou brûlure ; fermeture attendue si la cause est maîtrisée.

Chronique : évolution ralentie ; chercher une cause persistante et les facteurs du patient.

Pression : escarre par pression prolongée et/ou cisaillement.

Vasculaire : ulcère veineux ou artériel.

Neuropathique : souvent plantaire, liée à perte de sensibilité / appuis répétés.

Autres : inflammatoire, tumorale, infectieuse selon contexte.

2 • PHLYCTÈNE : LE CONTEXTE COMPTE

Phlyctène = cloque contenant du liquide, liée à un décollement cutané.

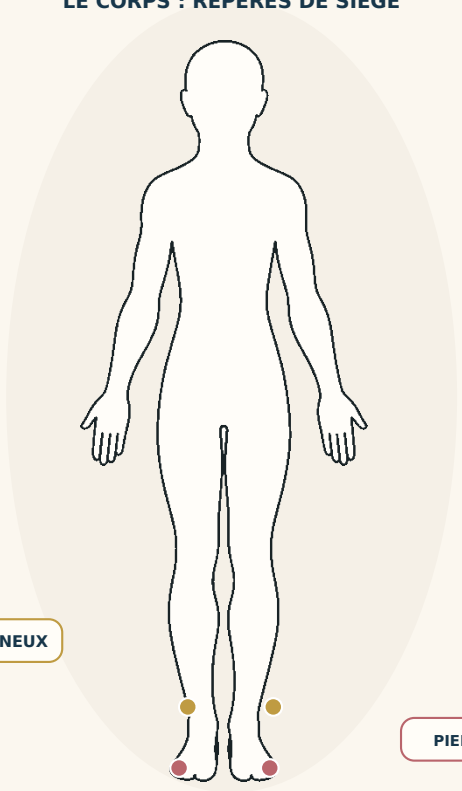
Brûlure du 2e degré superficiel : phlyctène, fond rose et humide, douleur vive ; blanchit à la pression.

Escarre catégorie 2 : perte partielle de peau / derme exposé ; phlyctène séreuse possible.

Phlyctène sanguine ou zone violacée sur appui : penser à une lésion tissulaire profonde.

Réflexe d'examen : préciser siège, mécanisme, aspect, douleur et évolution ; ne pas conclure sur le seul mot « cloque ».

LE CORPS : REPÈRES DE SIÈGE



DOS : occiput • sacrum • talons

3 • SIÈGES À REPÉRER

Appuis : sacrum, talons, trochanters, ischions, malléoles, occiput ; vérifier aussi sous les dispositifs.

Veineuse : péri-malléolaire (souvent interne), œdème, varices / dermite ocre, exsudat possible.

Artérielle : orteils, pied, talon ; froid, douleur, peau luisante, pouls diminués.

Neuropathique / diabétique : plante et zones d'appui ; sensibilité diminuée, callosités / déformations possibles.

4 • ESCARRE : CLASSIFICATION

Cat. 1 : peau intacte ; érythème persistant qui ne blanchit pas à la pression.

Cat. 2 : perte partielle d'épaisseur ; derme exposé, phlyctène séreuse possible.

Cat. 3 : perte de pleine épaisseur ; tissu adipeux visible, sans muscle / tendon / os exposé.

Cat. 4 : atteinte profonde ; fascia, muscle, tendon, cartilage ou os exposé / palpable.

Non classable : fond masqué par nécrose ou fibrine. Profonde : rouge foncé / violet persistant, phlyctène sanguine possible.

Prévenir : décharger, repositionner, limiter cisaillement ; ne jamais masser une rougeur persistante.

LES PLAIES • LES ESSENTIELS À L'EXAMEN

VERSO • Évaluer avant de choisir : les repères utiles pour raisonner et transmettre

5 • ÉVALUER ET DÉCRIRE (TRAME DE TRANSMISSION)

Patient / terrain : antécédents, diabète, tabac, nutrition, mobilité, perfusion, traitements / allergies, douleur.

Cause et plaie : étiologie, date, localisation, longueur × largeur (profondeur selon protocole), berges, décollement éventuel.

Fond et écoulement : tissus présents, exsudat (quantité, aspect, odeur), peau périlésionnelle, douleur et évolution comparée.

Examen : décrire les faits avant l'hypothèse ; la couleur seule ne suffit pas au choix du pansement.

6 • COULEURS DU LIT : INDICES, PAS DIAGNOSTIC

Noir : nécrose ; profondeur parfois masquée. Jaune : fibrine / enduit. Rouge : granulation vascularisée. Rose : épithélialisation.

Interpréter avec la cause, la perfusion, l'exsudat et les signes d'infection.

7 • CICATRISATION : 4 PHASES

Hémostase (minutes) → inflammation (jours) → prolifération (jours / semaines : granulation, angiogenèse, contraction, épithélialisation) → maturation (mois : remodelage du collagène).

Phases qui se chevauchent. Retards : infection, nécrose, ischémie, œdème / pression, macération, dénutrition, diabète déséquilibré, tabac, âge / comorbidités.

8 • PANSEMENTS : FONCTION + VIGILANCE

Hydrocolloïde : exsudat faible à modéré si adapté ; attention macération et peau fragile.

Hydrocellulaire : absorption et protection, exsudat modéré à abondant.

Hydrofibre / CMC : exsudat abondant ; se gélifie, maintien secondaire souvent nécessaire.

Alginate : exsudat abondant ; parfois hémostatique pour saignement mineur ; éviter plaie sèche.

Hydrogel : apporte de l'eau pour certaines plaies sèches ; vérifier la perfusion avant d'humidifier une nécrose.

Interface siliconée : protège granulation / épithélialisation, retrait atraumatique ; peu absorbante.

Film : plaie superficielle peu ou non exsudative ; n'absorbe pas.

Charbon : odeurs, en complément ; argent : usage ciblé, pas de routine sur simple colonisation.

9 • RÔLE IDE, SURVEILLANCE, ALERTES

Soin : expliquer, évaluer la douleur, hygiène des mains, retrait doux, nettoyage / détersion selon compétence et protocole ; tracer, transmettre, réévaluer.

Prévention escarre : inspection, décharge des talons, mobilisation / repositionnement, support adapté, maîtrise humidité et nutrition.

Alerter : fièvre, extension rapide, chaleur / rougeur qui s'étend, pus, nouvelle odeur, douleur croissante ou disproportionnée, nécrose évolutive, altération générale.

RÉFLEXE : cause / perfusion → infection ? → tissu → exsudat → peau / douleur → pansement adapté

Colonisation ≠ infection • sérum physiologique = nettoyage / rinçage, pas antiseptique • changement selon exsudat, dispositif et protocole